



CURSO PROFISSIONAL DE CUIDADOR

Bene Curati Cuidados

APOSTILA AMPLIADA • 200 HORAS

Base original: 160 horas

Conteúdo complementar: +40 horas

Total ampliado: 200 horas

Formação em Home Care, Cuidados Domiciliares e Assistência ao Paciente

1ª EDIÇÃO • 2026



CURSO PROFISSIONAL DE

CUIDADOR

Bene Curati Cuidados

**Formação em Home Care, Cuidados Domiciliares
e Assistência ao Paciente**

**Carga horária total: 160 horas
(padrão SENAC / qualificação profissional)**

Conteúdo detalhado • Atividades • Estudos de caso
Vídeos • Prova final (aprovação 70%)

1ª EDIÇÃO • 2026



Apresentação e Carga Horária

Esta apostila é o material oficial do Curso Profissional de Cuidador da Bene Curati Cuidados, estruturado em 160 horas (referência SENAC e práticas de qualificação profissional no Brasil). Modalidade presencial/híbrida: 160 h. Online teórico: até 120 h + prática supervisionada.

Cada módulo traz conteúdo detalhado, 5 questões de fixação, 1 estudo de caso e sugestão de vídeo. A Prova Final tem 20 questões (1 por módulo). Aprovação com 70% de acertos (14/20).

“Cuidar é um ato de ciência, responsabilidade e amor ao próximo.”



SUMÁRIO

1. Papel do Cuidador (6 h)
2. Ética e Humanização (8 h)
3. Anatomia e Fisiologia (8 h)
4. Envelhecimento e Doenças (10 h)
5. Biossegurança (8 h)
6. Sinais Vitais (10 h)
7. Higiene e Banho no Leito (10 h)
8. Decúbito e Prevenção de LPP (8 h)
9. Nutrição, Hidratação e Disfagia (8 h)
10. Medicamentos – Limites (6 h)
11. Sondas e Ostomias (6 h)
12. Curativos e Pele (6 h)
13. Mobilização e Prevenção de Quedas (10 h)
14. Alzheimer, Parkinson, AVC, DM, HAS (10 h)
15. Primeiros Socorros (10 h)
16. Cuidados Paliativos (6 h)
17. Comunicação e Família (6 h)
18. Diário de Bordo (6 h)
19. Autocuidado e Burnout (6 h)
20. Ética e Legislação (6 h)
21. Código de Excelência
22. PROVA FINAL + Gabarito

1. Apresentação e Papel do Cuidador

□ **Carga horária sugerida: 6 horas**

1.1 Quem é o cuidador profissional

O cuidador é o profissional que auxilia pessoas com limitações temporárias ou permanentes a realizar as atividades de vida diária (AVDs): higiene, alimentação, vestimenta, mobilidade, eliminações e organização do ambiente próximo ao paciente. Atua no domicílio (home care), em instituições de longa permanência ou em apoio hospitalar, sempre sob orientações da equipe de saúde (enfermeiro, médico, fisioterapeuta etc.).

O cuidador não substitui o enfermeiro, o técnico de enfermagem ou o médico. Seu trabalho é de apoio, observação e execução de cuidados básicos dentro do plano estabelecido pela equipe.

1.2 Principais atribuições

- Auxiliar na higiene pessoal (banho, higiene oral, vestimenta, cuidados com a pele)
- Ajudar na mobilidade e transferências (cama-cadeira, deambulação)
- Preparar e servir refeições conforme dieta prescrita
- Observar e relatar alterações no estado de saúde
- Aferir sinais vitais quando treinado e autorizado
- Lembrar o paciente dos horários de medicamentos (sem administrar injetáveis)
- Organizar o ambiente imediato do paciente (arrumação leve)
- Oferecer companhia e apoio emocional
- Documentar atividades e observações no Diário de Bordo
- Seguir o plano de cuidados e comunicar intercorrências

1.3 O que o cuidador NÃO faz

- Administrar medicamentos injetáveis ou realizar procedimentos invasivos
- Fazer curativos complexos ou alterar o plano de tratamento
- Diagnosticar doenças ou interpretar exames
- Tomar decisões clínicas independentes
- Realizar tarefas domésticas pesadas não relacionadas ao paciente

O escopo pode variar conforme legislação local e contrato. Sempre verifique as normas e o protocolo da Bene Curati Cuidados.

1.4 Perfil do bom profissional

Responsabilidade, empatia, observação, discrição, organização, paciência, comunicação clara e capacidade de trabalhar de forma independente, porém dentro dos limites da função e sob supervisão.

Atividades de Fixação

1. Qual a principal diferença entre o papel do cuidador e o do técnico de enfermagem?
2. Cite 3 competências essenciais de um bom cuidador.
3. Liste 4 atividades que o cuidador NÃO deve realizar sem habilitação.
4. Quais são os direitos básicos do paciente no cuidado domiciliar?
5. Por que o cuidador deve trabalhar sob supervisão da equipe de saúde?

Estudo de Caso

Dona Maria e a injeção

A filha pede que o cuidador administre uma injeção de vitamina que ela mesma comprou, dizendo que a mãe “melhora muito”.

Conduta esperada: Explicar com respeito que não pode administrar injetáveis. Orientar a procurar o médico ou a enfermagem. Registrar a solicitação e comunicar a supervisão.

Sugestão de Vídeo

► Papel do cuidador de idosos

https://www.youtube.com/results?search_query=papel+do+cuidador+de+idosos

2. Ética, Humanização e Postura Profissional

□ **Carga horária sugerida: 8 horas**

2.1 O que é ética profissional

Ética é o conjunto de princípios que orientam o comportamento correto, mesmo quando ninguém está observando. Para o cuidador, ser ético significa: honestidade, respeito à dignidade do paciente, cumprimento de horários, preservação de informações pessoais e atuação dentro dos limites técnicos.

2.2 Humanização

Humanizar é enxergar o paciente como pessoa — com história, sentimentos, medos, valores e preferências — e não apenas como “o caso” ou “a doença”. Pequenas atitudes fazem diferença: chamar pelo nome, explicar o que será feito, perguntar se está confortável e preservar a privacidade.

Exemplo: em vez de “Vamos dar banho”, diga: “Sr. João, está confortável para realizarmos seu banho agora? Vou ajudá-lo e preservar sua privacidade.”

2.3 Sigilo profissional e LGPD

Tudo o que o cuidador vê ou ouve durante o atendimento pertence ao paciente. É proibido divulgar diagnósticos, fotos, vídeos, medicamentos, problemas familiares ou endereço. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) trata dados de saúde como sensíveis. Nunca publique informações de pacientes em redes sociais, mesmo com “boa intenção”.

2.4 Aparência e comunicação

- Uniforme limpo, passado e identificado; unhas curtas; cabelos presos; sapato fechado
- Evitar perfumes fortes, maquiagem exagerada e acessórios em excesso
- Comunicação clara, objetiva, respeitosa; preferir o nome do paciente
- Escuta ativa: prestar atenção, não interromper, confirmar o entendimento

Atividades de Fixação

1. O que significa humanização no cuidado?
2. Cite 3 atitudes antiéticas que o cuidador nunca deve praticar.
3. Por que o sigilo continua após o término do atendimento?
4. Como deve ser a aparência profissional do cuidador?
5. O que fazer se a família pedir para esconder informação do paciente?

Estudo de Caso

Recusa do banho

Dona Helena, 84 anos, recusa o banho porque está triste após uma notícia da família. O cuidador insiste e força o procedimento.

Conduta esperada: Escutar com atenção, respeitar o momento, oferecer o banho novamente depois, registrar a recusa. Forçar nunca é adequado (exceto risco imediato à saúde).

Sugestão de Vídeo

► Sigilo Profissional – Coren SP
<https://www.youtube.com/watch?v=9BEwb30x4RQ>

3. Anatomia e Fisiologia Humana para Cuidadores

□ Carga horária sugerida: 8 horas

3.1 Organização do corpo humano

O organismo funciona de forma integrada: células → tecidos → órgãos → sistemas → organismo. Quando um sistema falha, outros podem ser afetados. O cuidador não diagnostica, mas observa e comunica alterações.

3.2 Principais sistemas e o que observar

Sistema	Função principal	Sinais de alerta para o cuidador
Nervoso	Comando: memória, movimentos, equilíbrio	Sonolência, confusão, fala enrolada, perda de força, convulsões
Respiratório	Trocas gasosas (O ₂ e CO ₂)	Falta de ar, chiado, tosse, lábios arroxeados, queda de SpO ₂
Cardiovascular	Transporte de O ₂ e nutrientes	Dor no peito, palpitações, PA alterada, edema, extremidades frias
Digestório	Digestão e absorção	Dificuldade para engolir, vômitos, diarreia, sangue nas fezes
Urinário	Eliminação de toxinas e equilíbrio hídrico	Pouca/ausência de urina, sangue, dor, odor forte, febre
Musculoesquelético	Movimento e postura	Dor intensa, dificuldade para andar, quedas, perda de força
Tegumentar (pele)	Proteção e controle de temperatura	Vermelhidão, feridas, bolhas, hematomas, lesões por pressão

3.3 Alterações do envelhecimento

Redução da força muscular, diminuição da visão e audição, pele mais fina, ossos mais frágeis, equilíbrio diminuído, reflexos mais lentos e alterações de memória. Essas mudanças aumentam o risco de quedas, infecções e complicações.

3.4 Sinais que exigem comunicação imediata

- Falta de ar intensa, dor no peito, desmaio, convulsão
- Febre persistente, confusão mental súbita, queda com trauma
- Sangramento importante, dificuldade para falar, fraqueza em um lado do corpo
- Ausência de resposta ao chamado

Dica Bene Curati: olhe o paciente antes de olhar os equipamentos. Mudanças na expressão, cor da pele, comportamento e respiração costumam aparecer antes das alterações nos aparelhos.

Atividades de Fixação

1. Qual sistema transporta oxigênio e nutrientes?
2. Cite 3 sinais de alerta do sistema nervoso.
3. Por que observar a pele diariamente em acamados?
4. Quais alterações do envelhecimento aumentam o risco de quedas?
5. O que significa “olhar o paciente antes dos equipamentos”?

Estudo de Caso

Sr. Antônio sonolento

Paciente normalmente conversador está sonolento, recusou o café e respira mais rápido que o habitual.

Conduta esperada: Verificar sinais vitais (se autorizado), manter seguro, comunicar imediatamente, registrar. Não medicar por conta própria.

Sugestão de Vídeo

► Anatomia básica para cuidadores

https://www.youtube.com/results?search_query=anatomia+fisiologia+cuidadores

4. Processo do Envelhecimento e Principais Doenças

□ Carga horária sugerida: 10 horas

4.1 Envelhecimento como processo individual

O envelhecimento é natural e varia de pessoa para pessoa. Nem todos os idosos têm as mesmas limitações. O cuidador deve conhecer as alterações esperadas e as doenças mais frequentes para oferecer cuidados adequados e identificar intercorrências precocemente.

4.2 Demências (incluindo Alzheimer)

Perda progressiva de memória, orientação e autonomia. O ambiente deve ser seguro e previsível. Use frases curtas, linguagem positiva e redirecionamento. Evite discussões. Identifique gatilhos de agitação (fome, dor, barulho, necessidade de banheiro). Nunca deixe o paciente sozinho em risco de fuga ou queda.

4.3 Parkinson

Tremor, rigidez, lentidão de movimentos e risco elevado de quedas. Atenção especial à marcha, ao equilíbrio e à deglutição. Use dispositivos de auxílio e acompanhe a deambulação.

4.4 AVC (sequelas)

Pode deixar hemiplegia, dificuldades de fala e deglutição. Apoie o lado afetado, previna contraturas, estimule a participação nas AVDs e observe sinais de novo evento neurológico (fala alterada, fraqueza súbita, assimetria facial).

4.5 Diabetes

Observe sinais de hipoglicemia (sudorese, tremores, confusão, fome, irritabilidade) e de hiperglicemia (sede excessiva, poliúria, sonolência, hálito cetônico). Siga a dieta e os horários de refeição. Comunique alterações imediatamente.

4.6 Hipertensão e doenças cardiovasculares

Controle de sal e líquidos quando orientado. Observe edema (inchaço), falta de ar, dor no peito e ganho de peso súbito. Relate valores de pressão muito altos ou muito baixos conforme o protocolo.

Atividades de Fixação

1. Cite 3 alterações fisiológicas típicas do envelhecimento.
2. Qual a principal preocupação de segurança em pacientes com Parkinson?
3. Como o cuidador deve abordar um paciente com hemiplegia pós-AVC?
4. Quais sinais de hipoglicemia o cuidador deve reconhecer?
5. Por que a rotina previsível é importante para pacientes com demência?

Estudo de Caso

Sr. José com Parkinson

Sr. José apresenta tremor e rigidez. A família pede que ele ande sozinho “para se fortalecer”. Ele quase cai.

Conduta esperada: Nunca deixar andar sozinho se houver risco. Usar dispositivo de auxílio, acompanhar de perto, comunicar a equipe e registrar.

Sugestão de Vídeo

► Doenças do idoso para cuidadores

https://www.youtube.com/results?search_query=doenças+do+idoso+cuidador

5. Biossegurança e Controle de Infecções

□ **Carga horária sugerida: 8 horas**

5.1 O que é biossegurança

Conjunto de medidas para prevenir acidentes, controlar infecções e proteger paciente, cuidador e família. A aplicação correta reduz a transmissão de microrganismos no ambiente domiciliar e institucional.

5.2 Higienização das mãos - técnica e momentos

É a medida mais eficaz. Lave com água e sabonete por 40-60 segundos: molhar, ensaboar, friccionar palmas, dorso, entre dedos, polegares, pontas dos dedos e punhos; enxaguar e secar com papel-toalha. Álcool 70% quando as mãos não estiverem visivelmente sujas.

Momentos essenciais:

- Antes de tocar o paciente e antes de preparar alimentos ou medicamentos
- Antes da higiene corporal e após contato com sangue, secreções ou excreções
- Após retirar as luvas, após usar o banheiro e ao iniciar/terminar o plantão

As luvas não substituem a higiene das mãos.

5.3 Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)

Luvas de procedimento, máscara cirúrgica, respirador PFF2/N95 (quando indicado), avental, óculos ou protetor facial. Use conforme o risco da atividade. Troque luvas entre procedimentos e pacientes. Nunca reutilize luvas descartáveis.

5.4 Descarte e acidentes com material biológico

Perfurocortantes (agulhas, lâminas, lancetas) vão em recipiente rígido apropriado — nunca no lixo comum. Em caso de exposição a sangue ou fluido: interrompa a atividade, lave imediatamente com água e sabão (não use água sanitária na pele), comunique o responsável e siga o protocolo da instituição.

Atividades de Fixação

1. Qual a medida mais eficaz para prevenir transmissão de infecções?
2. Cite 5 momentos em que o cuidador deve higienizar as mãos.
3. As luvas substituem a higiene das mãos? Justifique.
4. Como devem ser descartados materiais perfurocortantes?
5. O que fazer imediatamente após contato acidental com sangue?

Estudo de Caso

Luva rasgada

Durante o banho no leito a luva rasga ao contato com secreção da ferida.

Conduta esperada: Interromper com segurança, retirar a luva, higienizar as mãos, colocar novo par, comunicar exposição se houver contato com material biológico.

Sugestão de Vídeo

► Técnica de lavagem das mãos - Santa Casa de Maceió
https://www.youtube.com/watch?v=6EFG_u41LpE

6. Sinais Vitais e Avaliação Inicial

□ **Carga horária sugerida: 10 horas**

6.1 O que são sinais vitais

São parâmetros que indicam o funcionamento do organismo e ajudam a identificar se o paciente está estável ou se necessita de atenção imediata. Os principais são: temperatura, frequência cardíaca (pulso), frequência respiratória, pressão arterial, saturação de oxigênio e dor (considerada o 5º sinal vital). Em alguns pacientes também se aferem a glicemia capilar, quando houver treinamento e autorização.

O cuidador deve conhecer os valores de referência, saber utilizar corretamente os equipamentos e, principalmente, comparar com os valores basais daquele paciente. Mudanças súbitas ou valores fora do padrão devem ser comunicados imediatamente.

6.2 Temperatura corporal

Valores de referência (adulto): 36,0 °C a 37,5 °C (axilar). Acima de 37,8 °C pode indicar febre; abaixo de 35 °C, hipotermia.

Instrumentos: termômetro digital (axilar, oral ou timpânico), termômetro de infravermelho (testa/ouvido), termômetro de mercúrio (em desuso por risco ambiental e de quebra).

Técnica axilar (mais comum no domicílio): seque a axila, posicione o sensor no centro, mantenha o braço junto ao corpo, aguarde o bip ou o tempo indicado. Registre o valor e a via utilizada.

Cuidados: não aferir logo após banho quente, exercício ou ingestão de líquidos quentes/frios. Em idosos a resposta febril pode ser atenuada — observe também outros sinais (prostração, confusão).

6.3 Frequência cardíaca (pulso)

Valores de referência (adulto em repouso): 60 a 100 batimentos por minuto (bpm). Abaixo de 60: bradicardia; acima de 100: taquicardia.

Onde medir: pulso radial (punho), carotídeo (pescoço — com cuidado, um lado de cada vez), braquial, femoral ou apical (com estetoscópio, se treinado).

Técnica no pulso radial: use as polpas dos dedos indicador e médio (não o polegar, que tem pulso próprio). Conte por 60 segundos (ou 30 s × 2 se o ritmo for regular). Observe também ritmo (regular/irregular) e força.

Instrumentos: contagem manual; oxímetro de pulso (também mostra FC); monitor multiparâmetro em ambiente hospitalar.

6.4 Frequência respiratória

Valores de referência (adulto): 12 a 20 incursões por minuto (irpm). Abaixo: bradipneia; acima: taquipneia.

Técnica: observe o movimento do tórax ou abdômen sem avisar o paciente (a respiração muda se ele perceber). Conte por 60 segundos. Observe também profundidade, esforço, uso de musculatura acessória, ruídos (chiado, estertores) e cor dos lábios/unhas.

Instrumentos: observação direta; em alguns casos, monitor de sinais vitais ou capnógrafo (ambientes avançados).

6.5 Pressão arterial

Valores de referência (adulto): ideal abaixo de 120/80 mmHg. Hipertensão e hipotensão devem ser interpretadas conforme o basal do paciente e o protocolo da equipe.

Instrumentos: esfigmomanômetro aneroides ou digital (de braço ou de pulso), com manguito de tamanho adequado; estetoscópio para método auscultatório.

Técnica básica (braço): paciente em repouso, braço apoiado na altura do coração, manguito bem posicionado (2 cm acima da fossa cubital). Não falar durante a aferição. Registre sistólica e diastólica, braço utilizado e posição do paciente.

Cuidados: manguito pequeno superestima a PA; manguito grande subestima. Evite aferir sobre roupa grossa ou logo após esforço, café ou cigarro.

6.6 Saturação de oxigênio (SpO₂)

Valores de referência: geralmente $\geq 95\%$ em ar ambiente. Valores abaixo de 90–92% costumam exigir avaliação imediata (respeite o alvo individual do paciente, especialmente em DPOC).

Instrumento: oxímetro de pulso (sensor de dedo, orelha ou outro local). Verifique se as mãos estão quentes e sem esmalte escuro em excesso, que pode interferir. Se o paciente usa oxigênio, registre o fluxo e o dispositivo.

6.7 Dor (5º sinal vital)

Avalie localização, intensidade (escala de 0 a 10), caráter (queimação, pontada, peso), fatores que pioram ou aliviam e impacto no sono e nas atividades. Em pacientes com demência, use escalas comportamentais e observe expressão facial, agitação e recusa de movimento. Relate a dor e siga o protocolo de comunicação; não altere doses de analgésicos por conta própria.

6.8 Glicemia capilar (quando autorizado)

Realizada com glicosímetro e lanceta, conforme treinamento e prescrição. Conheça os alvos do paciente. Sinais de hipoglicemia exigem ação imediata conforme protocolo (oferecer açúcar rápido se consciente e orientado, comunicar etc.).

6.9 Registro e comunicação

Anote horário, valores, via/método e condições do paciente. Compare com o basal. Comunique imediatamente valores críticos ou mudanças súbitas. O registro no Diário de Bordo é obrigatório e protege o paciente e o profissional.

Atividades de Fixação

1. Quais são os principais sinais vitais avaliados pelo cuidador?
2. Qual a faixa de frequência respiratória considerada normal no adulto?
3. Por que é importante comparar os valores com o basal do paciente?
4. O que fazer se a saturação de oxigênio estiver abaixo de 90%?
5. A dor é considerada um sinal vital? Explique.

Estudo de Caso

PA 180 x 110 mmHg

Ao aferir a PA (conforme protocolo), o cuidador encontra 180 x 110 mmHg. O paciente refere leve dor de cabeça.

Conduta esperada: Manter em repouso, não administrar medicação por conta própria, comunicar imediatamente a enfermagem/supervisão, registrar e monitorar até orientação.

Sugestão de Vídeo

► Sinais Vitais – Aula Completa (Descomplica Enfermagem)

<https://www.youtube.com/watch?v=cL8FD8mSG0I>

7. Higiene Corporal e Banho no Leito

□ **Carga horária sugerida: 10 horas**

7.1 Importância da higiene

A higiene promove conforto, previne infecções e permite a inspeção da pele. Pode ser de aspersão (chuveiro), imersão ou no leito, conforme a condição do paciente e o plano de cuidados.

7.2 Princípios do banho

- Garantir privacidade (portas, cortinas, cobertura do corpo)
- Verificar temperatura da água (morna, cerca de 37–40 °C)
- Começar pelas áreas mais limpas e terminar pelas mais sujas
- Secar bem as dobras (axilas, virilha, sob as mamas, entre dedos)
- Observar a pele: vermelhidão, feridas, hematomas, ressecamento
- Estimular a participação do paciente sempre que possível
- Documentar qualquer alteração observada

7.3 Banho no leito - etapas gerais

Reúna o material (bacia, água morna, sabonete, toalhas, roupa limpa, luvas). Explique o procedimento. Proteja o colchão. Lave e seque por segmentos, mantendo o restante do corpo coberto. Troque a água se necessário. Ao final, vista o paciente, arrume a cama e deixe o ambiente organizado. Em pacientes com hemiplegia, comece a vestir pelo lado afetado e a despir pelo lado não afetado.

7.4 Higiene oral e eliminações

Higiene oral pelo menos duas vezes ao dia. Em dependentes, use gaze ou dispositivos específicos com cuidado para evitar aspiração. Observe gengivas e lesões. Nas eliminações, preserve dignidade; observe cor, odor e volume de urina e fezes; relate sangue, diarreia, constipação ou urina escura. Após eliminações, faça higiene perineal adequada, especialmente em incontinentes.

Atividades de Fixação

1. Quais são os princípios básicos do banho no leito?
2. Por que se deve começar pelas áreas mais limpas?
3. O que observar na pele durante a higiene?
4. Como proceder na higiene oral de paciente dependente?
5. Qual a importância da privacidade durante o banho?

Estudo de Caso

Vermelhidão no sacro

Durante o banho no leito o cuidador observa área avermelhada no sacro que não desaparece após alívio da pressão.

Conduta esperada: Registrar, comunicar a enfermagem imediatamente, evitar pressão adicional na região, manter a pele limpa e seca.

Sugestão de Vídeo

► Banho no leito – técnica validada (EPE Unifesp)
<https://www.youtube.com/watch?v=Y0woaEIMsXA>

8. Mudança de Decúbito e Prevenção de Lesão por Pressão

□ Carga horária sugerida: 8 horas

8.1 O que é lesão por pressão (LPP)

Dano na pele e/ou tecidos subjacentes, geralmente sobre proeminência óssea, resultante de pressão intensa e/ou prolongada, ou de pressão combinada com cisalhamento. Pacientes acamados ou com mobilidade reduzida têm alto risco.

8.2 Pontos de pressão mais comuns

Calcâneos, sacro, trocânteres (quadril), cotovelos, omoplatas, orelhas e região occipital. Em posição sentada: ísquios e cóccix.

8.3 Mudança de decúbito

Regra geral: a cada 2 horas (ou conforme o plano de cuidados). Use travesseiros e coxins para aliviar a pressão e manter alinhamento corporal. Evite arrastar o paciente (cisalhamento). Mantenha lençóis secos e sem rugas. Inspeccione a pele a cada mudança.

8.4 Sinais de alerta e conduta

Vermelhidão que não desaparece após alívio da pressão, área endurecida, bolha, ferida aberta ou odor. Comunique imediatamente a enfermagem. Não massageie áreas avermelhadas sobre proeminências ósseas.

Atividades de Fixação

1. Qual a frequência recomendada de mudança de decúbito?
2. Cite 4 pontos de pressão mais comuns.
3. O que fazer ao observar vermelhidão que não desaparece?
4. Por que lençóis secos e sem rugas são importantes?
5. Qual o papel dos coxins e travesseiros na prevenção?

Estudo de Caso

Falha de registro de decúbito

Paciente acamado; o plantão anterior não registrou mudança de decúbito nas últimas 5 horas.

Conduta esperada: Realizar a mudança imediatamente (se seguro), inspecionar a pele, comunicar a supervisão sobre a falha, documentar e reforçar a escala 2/2 h.

Sugestão de Vídeo

► 6 passos para prevenir lesão por pressão
<https://www.youtube.com/watch?v=DxVNsOwMZZ8>

9. Nutrição, Hidratação e Disfagia

▢ Carga horária sugerida: 8 horas

9.1 Alimentação segura

Siga rigorosamente a dieta prescrita (livre, pastosa, líquida, hipossódica, diabética etc.). Posicione o paciente sentado ou em semi-Fowler. Ofereça os alimentos na temperatura adequada. Respeite o ritmo e as preferências dentro da dieta. Estimule a autonomia. Registre a aceitação e intercorrências.

9.2 Hidratação

Ofereça líquidos regularmente, salvo restrição hídrica. Idosos frequentemente têm sede diminuída e risco de desidratação. Sinais: boca seca, urina concentrada, confusão, pele ressecada, tontura.

9.3 Disfagia

Dificuldade de deglutição. Sinais: engasgos, tosse durante a refeição, voz “molhada”, escape de alimento pela boca ou nariz, demora para engolir. Em caso de suspeita, interrompa a oferta oral e comunique a equipe. Nunca force a alimentação. Pacientes com AVC, Parkinson ou demência têm risco aumentado.

9.4 Sinais de alerta na alimentação

- Engasgos frequentes ou tosse durante as refeições (risco de aspiração)
- Recusa persistente de alimentos, náuseas, vômitos ou diarreia
- Perda de peso significativa ou sinais de desidratação

Atividades de Fixação

1. O que é disfagia e quais sinais o cuidador deve observar?
2. Por que o paciente deve estar sentado durante a refeição?
3. Cite sinais de desidratação no idoso.
4. O que fazer se o paciente engasgar durante a refeição?
5. Por que registrar a aceitação alimentar é importante?

Estudo de Caso

Engasgo durante o almoço

Durante o almoço o paciente começa a tossir intensamente e apresenta dificuldade para falar.

Conduta esperada: Interromper a oferta, estimular a tosse se possível, aplicar Heimlich se treinado e houver obstrução total, acionar emergência se necessário e comunicar a equipe.

Sugestão de Vídeo

► Disfagia e cuidados na alimentação do idoso

https://www.youtube.com/results?search_query=disfagia+cuidados+alimentação+idoso

10. Administração Segura de Medicamentos (Limites do Cuidador)

□ **Carga horária sugerida: 6 horas**

10.1 Papel do cuidador

Na maioria das situações o cuidador não administra medicamentos. Seu papel é de apoio, observação e registro, sempre seguindo o protocolo da Bene Curati Cuidados e a supervisão de enfermagem.

10.2 O que o cuidador pode fazer

- Lembrar o paciente do horário dos medicamentos
- Levar o frasco ou a cartela até o paciente (se autorizado)
- Observar se o paciente engoliu o medicamento
- Registrar se tomou ou recusou
- Reportar efeitos colaterais observados (náusea, sonolência, erupção etc.)

10.3 O que o cuidador NÃO deve fazer

- Preparar, calcular doses ou administrar injeções
- Alterar horários ou doses por conta própria
- Dar medicamentos de outra pessoa ou “emprestados”
- Esconder medicamentos ou forçar a ingestão

Em alguns contextos, após treinamento específico e autorização formal, o cuidador pode auxiliar na administração de medicamentos orais. Sempre siga a legislação e as políticas da Bene Curati Cuidados.

Atividades de Fixação

1. Quais ações o cuidador pode realizar em relação aos medicamentos?
2. Cite 4 ações que o cuidador NÃO deve realizar.
3. O que fazer se o paciente recusar o medicamento?
4. Por que não se deve “emprestar” medicamento de outro paciente?
5. Quando o cuidador pode auxiliar na administração de medicamentos orais?

Estudo de Caso

Pedido de aumento de dose

Um familiar pede para o cuidador “dar um pouco mais” do analgésico porque o paciente “sempre melhora”.

Conduta esperada: Explicar que não pode alterar a prescrição. Manter a dose prescrita. Comunicar a queixa de dor à enfermagem. Registrar a solicitação e a conduta.

Sugestão de Vídeo

► Os 9 certos da administração de medicamentos

https://www.youtube.com/results?search_query=9+certos+administração+medicamentos+enfermagem

11. Cuidados com Sondas e Ostomias (Observação e Apoio)

□ **Carga horária sugerida: 6 horas**

11.1 Limites do cuidador

O cuidador não realiza a passagem nem a troca de sondas. Seu papel é observar o funcionamento, manter a higiene do entorno, posicionar corretamente e comunicar alterações à enfermagem.

11.2 Pontos de observação em sondas

- Fixação adequada (sem tração excessiva)
- Aspecto e volume do conteúdo drenado ou residual
- Sinais de irritação ou lesão na pele ao redor
- Obstrução, refluxo ou saída acidental

11.3 Ostomias

Observe cor e aspecto do estoma (deve ser úmido e avermelhado/rosado), integridade da pele periostomal e vazamentos. Relate qualquer alteração (estoma pálido, escuro, retraído, sangramento, dermatite).

Atividades de Fixação

1. Qual o papel do cuidador em relação às sondas?
2. Cite 3 pontos de observação em pacientes com sonda nasoenteral.
3. O que fazer se a sonda sair acidentalmente?
4. Quais sinais de alerta observar em ostomias?
5. Por que a pele periostomal merece atenção especial?

Estudo de Caso

Sonda deslocada

Ao reposicionar o paciente, o cuidador percebe que a sonda nasoenteral está parcialmente para fora.

Conduta esperada: Não tentar reintroduzir. Fixar o que restou com segurança se possível, interromper dietas/medicações pela sonda, comunicar imediatamente a enfermagem e registrar.

Sugestão de Vídeo

► Cuidados com sonda nasoenteral

https://www.youtube.com/results?search_query=cuidados+sonda+nasoenteral+cuidador

12. Curativos Básicos e Cuidados com a Pele

□ **Carga horária sugerida: 6 horas**

12.1 Limites e observação

Curativos complexos são de responsabilidade da enfermagem. O cuidador pode realizar higiene simples da pele e curativos básicos apenas quando orientado e treinado, sempre sob protocolo.

Observe diariamente: vermelhidão, feridas, bolhas, hematomas, sinais de infecção (calor, pus, odor, aumento de dor ou secreção). Mantenha a pele limpa e hidratada. Relate qualquer alteração.

Atividades de Fixação

1. Qual a diferença entre curativo básico e curativo complexo?
2. Cite sinais de infecção em ferida que devem ser comunicados.
3. Por que a hidratação da pele é importante?
4. O cuidador pode realizar curativo sem orientação? Justifique.
5. O que observar em hematomas ou lesões novas?

Estudo de Caso

Ferida com odor e secreção

Ao trocar a roupa de cama o cuidador nota odor forte e secreção amarelada em uma lesão antiga.

Conduta esperada: Não manipular além do autorizado. Registrar aspecto, odor e quantidade. Comunicar imediatamente a enfermagem.

Sugestão de Vídeo

► Cuidados com feridas e pele

https://www.youtube.com/results?search_query=cuidados+pele+lesão+por+pressão+cuidador

13. Mobilização Segura, Transferências e Prevenção de Quedas

□ **Carga horária sugerida: 10 horas**

13.1 Mecânica corporal

- Mantenha a coluna reta e use a força das pernas (não das costas)
- Aproxime-se do paciente e mantenha base de apoio ampla
- Não gire o tronco enquanto carrega peso; movimente os pés
- Peça ajuda sempre que o paciente for pesado ou pouco colaborativo
- Use dispositivos auxiliares (cadeira de rodas, andador, cinto de transferência)

13.2 Transferências seguras

Antes de qualquer transferência: explique o que será feito, verifique calçados seguros, trave as rodas da cadeira/cama e posicione-se corretamente. Nunca puxe o paciente pelos braços. Em caso de dúvida, peça orientação ao fisioterapeuta ou enfermeiro.

13.3 Prevenção de quedas

- Ambiente organizado e bem iluminado; retirar obstáculos e tapetes soltos
- Barras de apoio no banheiro quando disponíveis
- Calçados antiderrapantes; evitar chinelos soltos
- Orientar a levantar-se lentamente (evitar hipotensão ortostática)
- Não deixar o paciente sozinho em situações de risco (banho, deambulação inicial)
- Observar efeitos de medicamentos que causam tontura ou sonolência

13.4 Após uma queda

Não levante imediatamente se houver suspeita de fratura ou trauma na cabeça. Avalie consciência, dor e mobilidade. Chame ajuda se necessário. Comunique a supervisão e registre o evento.

Atividades de Fixação

1. Cite 3 princípios de mecânica corporal.
2. Quando o cuidador deve pedir ajuda para transferir um paciente?
3. Liste 4 medidas de prevenção de quedas no domicílio.
4. Por que travar as rodas da cadeira/cama antes da transferência?
5. O que fazer imediatamente após uma queda do paciente?

Estudo de Caso

Quase queda no banheiro

O paciente tenta levantar-se sozinho do vaso sanitário e quase cai. O cuidador estava na cozinha.

Conduta esperada: Não deixar o paciente sozinho em situações de risco. Acompanhar no banheiro, usar barras de apoio, orientar a pedir ajuda. Registrar o quase-evento.

Sugestão de Vídeo

► Prevenção de quedas em idosos

https://www.youtube.com/results?search_query=prevenção+de+quedas+idosos+cuidador

14. Alzheimer, Parkinson, AVC, Diabetes e Hipertensão

□ **Carga horária sugerida: 10 horas**

14.1 Demência / Alzheimer - comunicação e segurança

- Use linguagem simples, calma e positiva; frases curtas
- Evite discussões; redirecione a atenção
- Ambiente seguro e previsível; rotinas consistentes
- Identifique gatilhos de agitação (fome, dor, barulho, necessidade de banheiro)
- Nunca deixe sozinho em risco de fuga ou queda
- Valorize as capacidades restantes e ofereça atividades significativas

14.2 Parkinson, AVC, diabetes e hipertensão

Parkinson: atenção à marcha, risco de quedas e deglutição.

AVC: apoiar o lado afetado, prevenir contraturas, observar sinais de novo evento neurológico.

Diabetes: sinais de hipoglicemia (sudorese, tremores, confusão) e hiperglicemia (sede, poliúria).

Hipertensão / insuficiência cardíaca: controle de líquidos e sal quando orientado; observar edema e dispneia.

Atividades de Fixação

1. Como o cuidador deve responder a um paciente com Alzheimer que pergunta repetidamente pela mãe falecida?
2. Quais sinais de hipoglicemia devem ser reconhecidos?
3. Por que não se deve confrontar a realidade em pacientes com demência avançada?
4. Como apoiar o paciente com hemiplegia no vestir-se?
5. Cite 2 cuidados específicos no Parkinson.

Estudo de Caso

Pergunta repetida sobre a mãe

Dona Helena (Alzheimer moderado) pergunta pela quinta vez: “Minha mãe já chegou?”. O cuidador responde com impaciência: “Sua mãe morreu há anos!”.

Conduta esperada: Manter a calma, validar o sentimento, não confrontar a memória, redirecionar a conversa para algo reconfortante e oferecer apoio emocional.

Sugestão de Vídeo

► Cuidados com paciente com Alzheimer

https://www.youtube.com/results?search_query=cuidados+paciente+alzheimer+cuidador

15. Primeiros Socorros e Emergências

□ **Carga horária sugerida: 10 horas**

15.1 Princípios gerais

Em qualquer emergência: mantenha a calma, avalie a segurança da cena, chame ajuda (SAMU 192) e avise a supervisão/agência. É altamente recomendável treinamento atualizado em Primeiros Socorros e RCP (BLS).

15.2 Situações frequentes

Queda: não levante imediatamente se houver suspeita de fratura ou trauma craniano. Avalie consciência e dor. Chame ajuda se necessário.

Engasgo: se tossir, incentive. Se não respirar/falar, manobra de Heimlich (se treinado) + emergência.

Convulsão: proteja a cabeça, retire objetos próximos, não introduza nada na boca, cronometre. Após a crise, posição lateral de segurança.

Dor torácica / suspeita de infarto: repouso + emergência imediatamente.

Parada cardiorrespiratória: RCP se treinado e certificado + emergência + DEA se disponível e treinado.

Atividades de Fixação

1. Qual o primeiro passo em qualquer emergência?
2. Como proceder em caso de engasgo com obstrução total (paciente consciente)?
3. O que fazer durante uma convulsão?
4. Por que não se deve levantar imediatamente um paciente após queda com suspeita de fratura?
5. Qual o número de emergência médica no Brasil?

Estudo de Caso

Engasgo durante a refeição

Paciente consciente, não consegue falar nem tossir, leva as mãos à garganta.

Conduta esperada: Aplicar manobra de Heimlich (se treinado), acionar o SAMU 192, avisar a supervisão e registrar. Se perder a consciência, iniciar RCP se treinado.

Sugestão de Vídeo

► Manobra de Heimlich – Einstein

<https://www.youtube.com/watch?v=C2c0BIJygYI>

16. Cuidados Paliativos

□ **Carga horária sugerida: 6 horas**

16.1 Conceito e objetivos

Cuidados paliativos visam aliviar o sofrimento e promover qualidade de vida quando a doença não tem perspectiva de cura. O foco é o conforto, o controle de sintomas e o apoio emocional ao paciente e à família.

16.2 Papel do cuidador

Contribui com higiene, posicionamento, alívio de dor (conforme prescrição), presença e escuta. Respeite as decisões do paciente e da família. Mantenha a dignidade em todos os momentos. Em caso de óbito, siga o protocolo da empresa e apoie a família com serenidade.

Atividades de Fixação

1. Qual o principal objetivo dos cuidados paliativos?
2. Como o cuidador contribui no cuidado paliativo?
3. O que fazer em caso de óbito no domicílio (conduta geral)?
4. Por que a presença e a escuta são importantes nessa fase?
5. Como preservar a dignidade do paciente em cuidados paliativos?

Estudo de Caso

Paciente em cuidados paliativos com dor

Paciente em cuidados paliativos refere dor intensa. O familiar pede “qualquer coisa” para aliviar.

Conduta esperada: Não administrar medicação além da prescrita. Comunicar imediatamente a enfermagem/médico, registrar a queixa e manter o paciente confortável até a avaliação.

Sugestão de Vídeo

► Cuidados paliativos para cuidadores

https://www.youtube.com/results?search_query=cuidados+paliativos+para+cuidadores

17. Comunicação com a Família e Trabalho em Equipe

□ **Carga horária sugerida: 6 horas**

17.1 Relação com a família

A família também precisa de acolhimento. Pode sentir medo, culpa, ansiedade e cansaço. Mantenha postura profissional, esclareça apenas o autorizado, comunique alterações conforme protocolo e evite discussões.

17.2 Trabalho multiprofissional

O cuidado é multiprofissional. Respeite médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e demais profissionais. A comunicação deve ser clara e profissional. O Diário de Bordo e a passagem de plantão são instrumentos essenciais de continuidade do cuidado.

Atividades de Fixação

1. Como o cuidador deve agir diante de um conflito com familiar?
2. O que nunca se deve dizer a um paciente ou familiar em sofrimento?
3. Por que a passagem de plantão é importante?
4. Cite 3 atitudes de escuta ativa.
5. Como manter limites profissionais com a família?

Estudo de Caso

Familiar irritado com atraso

O familiar chega e encontra o paciente ainda sem o banho (atraso de 40 minutos por intercorrência anterior). Começa a elevar o tom de voz.

Conduta esperada: Manter a calma, explicar objetivamente o ocorrido, pedir desculpas pelo atraso, realizar o cuidado e registrar. Não discutir. Se necessário, acionar a supervisão.

Sugestão de Vídeo

► Comunicação humanizada no cuidado

https://www.youtube.com/results?search_query=comunicação+humanizada+cuidador+idoso

18. Diário de Bordo e Documentação

□ **Carga horária sugerida: 6 horas**

18.1 Importância do registro

O Diário de Bordo é documento oficial da Bene Curati Cuidados. Deve ser verdadeiro, objetivo, legível, completo e realizado logo após o cuidado. Protege o paciente e o profissional. Nunca altere ou apague informações para esconder um erro.

18.2 O que registrar

- Sinais vitais (quando aferidos)
- Administração/lembrete de medicamentos e recusas
- Alimentação, hidratação e eliminações
- Higiene, mudança de decúbito e mobilidade
- Queixas, alterações de comportamento e intercorrências
- Comunicações com a família e com a equipe

Atividades de Fixação

1. Quais características um bom registro no Diário de Bordo deve ter?
2. O que deve ser registrado obrigatoriamente?
3. Por que não se deve apagar ou rasurar informações?
4. Qual a importância do registro para a segurança jurídica do cuidador?
5. Quando registrar uma intercorrência?

Estudo de Caso

Esquecimento de registro

O cuidador percebe no final do plantão que esqueceu de anotar a mudança de decúbito das 14h.

Conduta esperada: Registrar o mais próximo possível do horário real, com honestidade. Nunca inventar. Comunicar a supervisão se o atraso for relevante e seguir o protocolo de correção da empresa.

Sugestão de Vídeo

► Importância do registro de enfermagem

https://www.youtube.com/results?search_query=importancia+do+registro+de+enfermagem

19. Saúde Mental, Autocuidado e Prevenção de Burnout

▢ **Carga horária sugerida: 6 horas**

19.1 O cuidador também é humano

O cuidador convive diariamente com sofrimento, dor, limitações e, muitas vezes, perdas. Jornadas prolongadas e responsabilidade constante afetam a saúde física e emocional. Reconhecer isso é sinal de maturidade profissional.

19.2 Estresse e Burnout

Sinais de estresse: irritabilidade, dificuldade para dormir, dores de cabeça, tensão muscular, cansaço constante. Burnout é esgotamento físico, mental e emocional ligado ao trabalho: perda de motivação, distanciamento emocional dos pacientes, sensação de incapacidade. É condição séria e deve ser avaliada por profissionais de saúde.

19.3 Prevenção

- Organização da rotina e respeito aos horários de descanso
- Sono adequado e alimentação regular
- Atividade física (mesmo caminhadas)
- Ergonomia correta (não levantar paciente sozinho quando precisa de duas pessoas)
- Separar vida profissional e pessoal ao final do plantão
- Pedir ajuda e buscar apoio quando necessário

Atividades de Fixação

1. O que é a Síndrome de Burnout e quais seus principais sinais?
2. Cite 5 medidas que ajudam a prevenir o esgotamento profissional.
3. Por que a ergonomia é importante na rotina do cuidador?
4. Em quais situações procurar ajuda profissional para a própria saúde mental?
5. Por que o autocuidado também é uma forma de proteger o paciente?

Estudo de Caso

Maria e os plantões consecutivos

Maria trabalha há 4 anos. Nos últimos meses faz plantões seguidos, dorme pouco, está irritada e sente que “não consegue mais cuidar como antes”.

Conduta esperada: Reconhecer possível sobrecarga/burnout. Reorganizar a rotina, buscar apoio da coordenação e avaliação de saúde, priorizar descanso e autocuidado.

Sugestão de Vídeo

► Prevenção de burnout em profissionais de saúde

https://www.youtube.com/results?search_query=prevenção+burnout+profissionais+de+saúde

20. Ética, Legislação e Responsabilidade Profissional

▢ **Carga horária sugerida: 6 horas**

20.1 Princípios éticos

Respeito, beneficência (fazer o bem), não maleficência (não causar dano) e justiça. Todo paciente merece dignidade, independentemente de idade, condição financeira, religião ou deficiência.

20.2 Negligência, imprudência e imperícia

Negligência: deixar de fazer o que deveria (ex.: não mudar o decúbito).

Imprudência: agir de forma precipitada (ex.: transferir sem travar a cadeira).

Imperícia: executar atividade para a qual não tem habilitação (ex.: tentar recolocar sonda).

20.3 LGPD e redes sociais

Dados de saúde são sensíveis. É proibido publicar fotos, vídeos, quartos, receitas ou comentários sobre o atendimento em redes sociais. O sigilo permanece mesmo após o término do atendimento.

Atividades de Fixação

1. Explique a diferença entre negligência, imprudência e imperícia.
2. Quais informações sobre o paciente devem permanecer em sigilo?
3. Cite 5 deveres fundamentais do cuidador profissional.
4. Como o cuidador deve agir se um familiar solicitar a alteração de um medicamento?
5. Por que os registros no Diário de Bordo são importantes juridicamente?

Estudo de Caso

Pedido de alteração de dose

Familiar solicita aumento da dose do analgésico alegando que “sempre melhora”.

Conduta esperada: Explicar que não pode alterar a prescrição. Manter a dose prescrita. Comunicar a queixa à enfermagem. Registrar tudo.

Sugestão de Vídeo

► Código de Ética e responsabilidade profissional
<https://www.youtube.com/watch?v=9BEwb30x4RQ>



Código de Excelência Bene Curati Cuidados

Ao vestir o uniforme de Cuidador, o profissional assume o compromisso de:

- ✓ Cuidar com ética e responsabilidade
- ✓ Respeitar a dignidade de cada pessoa
- ✓ Comunicar-se com clareza e gentileza
- ✓ Trabalhar em equipe e atualizar-se
- ✓ Proteger a privacidade do paciente
- ✓ Tratar cada vida como única

Na Bene Curati Cuidados, competência técnica e coração caminham juntos.

PROVA FINAL

20 questões (1 por módulo). Aprovação: mínimo 14 acertos (70%). Carga sugerida: 6 h (revisão + prova).

1. O cuidador pode administrar injetáveis se a família autorizar? () Sim () Não. Justifique.
2. Cite 2 atitudes de humanização no cuidado.
3. Qual sistema é responsável pelas trocas gasosas?
4. Cite 2 sinais de alerta em diabetes.
5. As luvas substituem a higiene das mãos? () Sim () Não.
6. Faixa normal de FC no adulto em repouso?
7. No banho no leito, começa pelas áreas limpas ou sujas?
8. Frequência geral de mudança de decúbito em acamado?
9. O que é disfagia?
10. O cuidador pode aumentar dose de analgésico se houver dor? () Sim () Não.
11. Se a sonda sair, o cuidador deve recolocá-la? () Sim () Não.
12. Cite 2 sinais de infecção em ferida.
13. Cite 3 medidas de prevenção de quedas.
14. Como responder paciente com Alzheimer que insiste em “ir trabalhar”?
15. Número do SAMU no Brasil?
16. Principal objetivo dos cuidados paliativos?
17. Deve discutir com familiar em discordância? () Sim () Não.
18. O registro pode ser feito no dia seguinte de memória? () Sim () Não. Justifique.
19. Cite 2 sinais de possível burnout.
20. Diferença entre negligência e imperícia?

GABARITO DA PROVA FINAL (Referência)

1. Não. Extrapola o escopo; exige habilitação.
2. Chamar pelo nome, explicar o procedimento, preservar privacidade, escutar.
3. Sistema respiratório.
4. Hipo: sudorese, tremores, confusão. Hiper: sede, poliúria.
5. Não.
6. 60 a 100 bpm.
7. Áreas mais limpas.
8. A cada 2 horas (ou conforme plano).
9. Dificuldade de deglutição.
10. Não.
11. Não.
12. Calor, pus, odor, vermelhidão, aumento de dor/secreção.
13. Ambiente organizado/iluminado, calçados adequados, barras, não deixar sozinho em risco.
14. Não confrontar; validar e redirecionar com calma.
15. 192.
16. Aliviar sofrimento e promover conforto/dignidade.
17. Não.
18. Não. Deve ser próximo do cuidado, verdadeiro e objetivo.
19. Irritabilidade, cansaço extremo, perda de motivação, distanciamento.
20. Negligência = deixar de fazer. Imperícia = fazer sem habilitação.

Parabéns por concluir a formação de 160 horas!



Bene Curati Cuidados — 1ª Edição 2026

Material oficial de formação. Todos os direitos reservados.



CADERNO COMPLEMENTAR

CURSO PROFISSIONAL DE CUIDADOR

Ampliação de 160 horas para 200 horas

Este caderno acrescenta 40 horas de formação à apostila original: 2 horas complementares para cada um dos 20 temas numerados. A estrutura, terminologia, fonte e paleta visual foram mantidas em alinhamento com o material original.

1ª EDIÇÃO • 2026

Como utilizar a ampliação

A apostila original permanece como base de 160 horas. O presente caderno acrescenta conteúdo teórico e atividades aos mesmos 20 módulos, totalizando 40 horas adicionais. Assim, a carga formativa ampliada passa a 200 horas.

Distribuição da carga horária

Módulo	Tema	Base	Complementar	Total
1	Papel do Cuidador	6 h	2 h	8 h
2	Ética e Humanização	8 h	2 h	10 h
3	Anatomia e Fisiologia	8 h	2 h	10 h
4	Envelhecimento e Doenças	10 h	2 h	12 h
5	Biossegurança	8 h	2 h	10 h
6	Sinais Vitais	10 h	2 h	12 h
7	Higiene e Banho no Leito	10 h	2 h	12 h
8	Decúbito e Prevenção de LPP	8 h	2 h	10 h
9	Nutrição, Hidratação e Disfagia	8 h	2 h	10 h
10	Medicamentos - Limites	6 h	2 h	8 h
11	Sondas e Ostomias	6 h	2 h	8 h
12	Curativos e Pele	6 h	2 h	8 h
13	Mobilização, Transferências e Quedas	10 h	2 h	12 h
14	Alzheimer, Parkinson, AVC, DM e HAS	10 h	2 h	12 h
15	Primeiros Socorros	10 h	2 h	12 h
16	Cuidados Paliativos	6 h	2 h	8 h
17	Comunicação e Família	6 h	2 h	8 h
18	Diário de Bordo	6 h	2 h	8 h
19	Autocuidado e Burnout	6 h	2 h	8 h
20	Ética e Legislação	6 h	2 h	8 h

Total adicional: 40 horas • Nova carga horária: 200 horas.

1. Papel do Cuidador — Conteúdo Complementar

Carga adicional: 2 horas

Aprofundamento

A atuação profissional começa pelo reconhecimento dos limites da função. O cuidador participa do plano de cuidado, observa mudanças, apoia as atividades de vida diária e comunica intercorrências. O cuidado seguro depende de saber diferenciar apoio, observação e execução de cuidados básicos de procedimentos que exigem habilitação específica.

Conteúdos complementares

- 1.1 Rotina e plano de cuidados: conferir orientações, prioridades, horários e riscos antes de iniciar o plantão.
- 1.2 Autonomia e segurança: incentivar o paciente a participar das AVDs sem assumir tarefas que ele consegue realizar com segurança.
- 1.3 Continuidade do cuidado: comunicar mudanças de comportamento, alimentação, mobilidade, eliminações e sinais vitais quando autorizados.
- 1.4 Limites profissionais: diante de uma solicitação fora do escopo, interromper a ação, explicar o limite e acionar a supervisão.
- 1.5 Organização do plantão: separar cuidados essenciais, observações e registros para evitar esquecimentos.

Atividades Complementares

1. Explique por que conhecer os limites da função é parte da segurança do paciente.
2. Em que situações o cuidador deve acionar a supervisão antes de continuar uma atividade?
3. Como incentivar a autonomia sem abandonar a pessoa em situação de risco?
4. Quais informações de um plantão devem ser comunicadas para favorecer a continuidade do cuidado?
5. Um familiar pede ao cuidador um procedimento fora de sua função. Qual deve ser a sequência de condutas?

Orientação de estudo: responda às questões com base no conteúdo do módulo original e neste aprofundamento. Quando houver dúvida sobre uma conduta prática, prevalecem o plano de cuidados, o protocolo institucional e a orientação da equipe responsável.

2. Ética e Humanização — Conteúdo Complementar

Carga adicional: 2 horas

Aprofundamento

A ética cotidiana aparece em decisões simples: pedir consentimento, preservar privacidade, cumprir horários, manter sigilo e tratar a pessoa com respeito. Humanizar não significa fazer tudo o que o paciente pede; significa reconhecer sua história, suas escolhas e seus direitos, mantendo a segurança e os limites profissionais.

Conteúdos complementares

2.1 Consentimento e participação: explicar o cuidado antes de realizá-lo e verificar se a pessoa compreendeu.

2.2 Privacidade: cobrir o corpo durante higiene, evitar conversas sobre o paciente em locais inadequados e proteger documentos.

2.3 Comunicação não violenta: descrever fatos, evitar julgamentos e encaminhar conflitos à supervisão quando necessário.

2.4 Redes sociais: não publicar imagens, relatos ou informações que permitam identificar o paciente.

2.5 Postura profissional: manter cordialidade sem confundir vínculo de cuidado com amizade íntima ou exposição pessoal.

Atividades Complementares

1. Por que pedir consentimento antes de um cuidado contribui para a humanização?
2. Cite três formas de preservar a privacidade durante o atendimento.
3. Como agir diante de uma discussão com familiar sem perder a postura profissional?
4. Por que fotos e vídeos do paciente não devem ser publicados em redes sociais?
5. Qual a diferença entre ser acolhedor e ultrapassar os limites profissionais?

Orientação de estudo: responda às questões com base no conteúdo do módulo original e neste aprofundamento. Quando houver dúvida sobre uma conduta prática, prevalecem o plano de cuidados, o protocolo institucional e a orientação da equipe responsável.

3. Anatomia e Fisiologia — Conteúdo Complementar

Carga adicional: 2 horas

Aprofundamento

O conhecimento funcional do corpo ajuda o cuidador a observar alterações sem transformar observação em diagnóstico. É útil relacionar cada sistema às manifestações que podem ser percebidas durante a rotina e ao que deve ser comunicado à equipe.

Conteúdos complementares

- 3.1 Sistema nervoso: observar consciência, orientação, fala, força e equilíbrio.
- 3.2 Sistema respiratório: observar frequência, esforço, tosse, ruídos e coloração.
- 3.3 Sistema cardiovascular: observar pulso, pressão quando autorizado, edema, dor torácica e tolerância ao esforço.
- 3.4 Sistema digestório e urinário: acompanhar alimentação, deglutição, vômitos, fezes, urina e hidratação.
- 3.5 Pele e musculoesquelético: observar integridade da pele, dor, mobilidade, postura e risco de quedas.

Atividades Complementares

1. Por que o cuidador deve observar sistemas do corpo sem diagnosticar?
2. Cite dois sinais que podem indicar alteração neurológica.
3. Quais aspectos da respiração podem ser observados além da frequência?
4. Que alterações da pele merecem registro e comunicação?
5. Por que comparar o estado atual com o padrão habitual do paciente é importante?

Orientação de estudo: responda às questões com base no conteúdo do módulo original e neste aprofundamento. Quando houver dúvida sobre uma conduta prática, prevalecem o plano de cuidados, o protocolo institucional e a orientação da equipe responsável.

4. Envelhecimento e Doenças — Conteúdo Complementar

Carga adicional: 2 horas

Aprofundamento

O envelhecimento apresenta mudanças graduais e individuais. O cuidador deve distinguir alterações esperadas de mudanças novas ou intensas. A observação de padrões anteriores do paciente ajuda a reconhecer intercorrências e a comunicar a equipe com precisão.

Conteúdos complementares

4.1 Mudanças sensoriais: adaptar iluminação, comunicação e ambiente sem infantilizar o idoso.

4.2 Fragilidade e reserva funcional: pequenas intercorrências podem produzir maior impacto, exigindo atenção a mudanças sutis.

4.3 Rotina e comportamento: alterações repentinas de sono, apetite, humor ou orientação merecem registro e comunicação.

4.4 Doenças crônicas: conhecer o plano de cuidado e os sinais de alerta definidos para cada paciente.

4.5 Prevenção: organizar ambiente, alimentação, hidratação, mobilidade e acompanhamento conforme orientação da equipe.

Atividades Complementares

1. Por que dois idosos da mesma idade podem apresentar capacidades diferentes?
2. Cite três mudanças sensoriais ou funcionais comuns no envelhecimento.
3. Quais mudanças comportamentais repentinas merecem atenção?
4. Como a organização do ambiente pode reduzir riscos para pessoas frágeis?
5. Por que doenças crônicas exigem acompanhamento conforme plano individual?

Orientação de estudo: responda às questões com base no conteúdo do módulo original e neste aprofundamento. Quando houver dúvida sobre uma conduta prática, prevalecem o plano de cuidados, o protocolo institucional e a orientação da equipe responsável.

5. Biossegurança — Conteúdo Complementar

Carga adicional: 2 horas

Aprofundamento

Biossegurança é uma prática contínua. Além da higiene das mãos, envolve organização do ambiente, uso correto de EPIs, manejo de resíduos e resposta adequada a exposições. A regra central é reduzir a possibilidade de transmissão e acidente antes que o problema aconteça.

Conteúdos complementares

5.1 Higiene das mãos: realizar nos momentos indicados e usar técnica adequada.

5.2 Uso de luvas: colocar quando houver risco de contato com sangue, secreções ou excreções e trocar entre procedimentos.

5.3 Limpeza do ambiente: manter superfícies e materiais organizados, respeitando produtos e protocolos definidos.

5.4 Resíduos: separar materiais conforme orientação do serviço; perfurocortantes nunca devem ir ao lixo comum.

5.5 Exposição acidental: interromper, higienizar a área atingida, comunicar e seguir o protocolo institucional.

Atividades Complementares

1. Qual é o objetivo principal da biossegurança?
2. Por que as luvas não substituem a higiene das mãos?
3. Quando o cuidador deve trocar as luvas durante um cuidado?
4. Como agir diante de uma exposição acidental a sangue?
5. Por que perfurocortantes exigem recipiente específico?

Orientação de estudo: responda às questões com base no conteúdo do módulo original e neste aprofundamento. Quando houver dúvida sobre uma conduta prática, prevalecem o plano de cuidados, o protocolo institucional e a orientação da equipe responsável.

6. Sinais Vitais — Conteúdo Complementar

Carga adicional: 2 horas

Aprofundamento

A qualidade da aferição depende tanto do equipamento quanto das condições do paciente. Repouso, posição, tamanho adequado do manguito e registro completo são fundamentais. O valor isolado não deve ser interpretado fora do contexto e do padrão individual.

Conteúdos complementares

6.1 Preparação: explicar o procedimento, garantir repouso e escolher equipamento adequado.

6.2 Temperatura: registrar valor e via utilizada; observar sintomas associados.

6.3 Pulso e respiração: observar frequência, ritmo, esforço e alterações em relação ao habitual.

6.4 Pressão arterial: registrar sistólica/diastólica, braço, posição e condições da aferição.

6.5 SpO₂ e dor: considerar fatores que interferem na leitura e registrar sintomas, contexto e resposta do paciente.

Atividades Complementares

1. Quais fatores podem interferir na qualidade de uma aferição de pressão arterial?
2. Por que o valor basal do paciente deve ser considerado?
3. O que deve ser registrado após aferir um sinal vital?
4. Quais aspectos da respiração devem ser observados além do número de incursões?
5. Por que dor deve ser investigada mesmo quando não há alteração aparente nos demais sinais?

Orientação de estudo: responda às questões com base no conteúdo do módulo original e neste aprofundamento. Quando houver dúvida sobre uma conduta prática, prevalecem o plano de cuidados, o protocolo institucional e a orientação da equipe responsável.

7. Higiene e Banho no Leito — Conteúdo Complementar

Carga adicional: 2 horas

Aprofundamento

A higiene é também um momento de avaliação e comunicação. O cuidador deve equilibrar conforto, privacidade, segurança térmica e participação do paciente. A organização prévia evita deixar a pessoa exposta ou interromper o cuidado para buscar materiais.

Conteúdos complementares

- 7.1 Planejamento: separar materiais antes do banho e deixar roupas limpas disponíveis.
- 7.2 Privacidade: cobrir as áreas que não estão sendo higienizadas e explicar cada etapa.
- 7.3 Pele: observar ressecamento, vermelhidão, lesões, hematomas e regiões de dobra.
- 7.4 Higiene oral: adaptar a técnica ao nível de dependência e ao risco de aspiração.
- 7.5 Finalização: secar dobras, vestir, reposicionar, organizar o leito e registrar alterações.

Atividades Complementares

1. Por que o banho deve ser planejado antes de começar?
2. Como preservar a privacidade durante o banho no leito?
3. Quais regiões da pele merecem atenção especial por acumularem umidade?
4. Como estimular a participação de um paciente parcialmente dependente?
5. O que deve ser feito ao encontrar uma alteração de pele durante a higiene?

Orientação de estudo: responda às questões com base no conteúdo do módulo original e neste aprofundamento. Quando houver dúvida sobre uma conduta prática, prevalecem o plano de cuidados, o protocolo institucional e a orientação da equipe responsável.

8. Decúbito e Prevenção de LPP — Conteúdo Complementar

Carga adicional: 2 horas

Aprofundamento

A prevenção de lesões por pressão exige combinação de alívio de pressão, inspeção da pele, controle de umidade e posicionamento. O plano individual pode modificar frequência e recursos; por isso, a orientação da equipe deve prevalecer sobre uma regra isolada.

Conteúdos complementares

- 8.1 Avaliação da pele: observar proeminências ósseas em cada mudança de posição.
- 8.2 Alinhamento: usar travesseiros e coxins para distribuir pressão e manter postura.
- 8.3 Cisalhamento: evitar arrastar o paciente e utilizar técnicas e recursos adequados.
- 8.4 Umidade: trocar roupas e lençóis úmidos e realizar higiene adequada após eliminações.
- 8.5 Registro: documentar posições, alterações de pele e medidas tomadas conforme protocolo.

Atividades Complementares

1. Quais fatores contribuem para o aparecimento de lesão por pressão?
2. Por que arrastar o paciente pode prejudicar a pele?
3. Qual a função dos coxins e travesseiros?
4. Por que a inspeção da pele deve ocorrer de forma sistemática?
5. O que fazer diante de vermelhidão persistente em uma proeminência óssea?

Orientação de estudo: responda às questões com base no conteúdo do módulo original e neste aprofundamento. Quando houver dúvida sobre uma conduta prática, prevalecem o plano de cuidados, o protocolo institucional e a orientação da equipe responsável.

9. Nutrição, Hidratação e Disfagia — Conteúdo Complementar

Carga adicional: 2 horas

Aprofundamento

A alimentação segura combina dieta prescrita, posicionamento, ritmo adequado e observação. O cuidador deve respeitar restrições e reconhecer sinais de disfagia. Quando houver suspeita de risco de aspiração, a oferta oral deve ser interrompida e a equipe comunicada.

Conteúdos complementares

9.1 Preparação: conferir dieta, consistência, restrições e posição indicada.

9.2 Ritmo: oferecer pequenas quantidades no ritmo do paciente, sem pressa ou distrações desnecessárias.

9.3 Hidratação: distribuir ofertas ao longo do dia quando não houver restrição.

9.4 Disfagia: observar tosse, engasgos, voz alterada e dificuldade para deglutir.

9.5 Registro: anotar aceitação, recusa, intercorrências e sinais de desidratação conforme orientação.

Atividades Complementares

1. Por que a consistência da dieta deve ser respeitada?
2. Cite quatro sinais que podem sugerir disfagia.
3. Quais medidas ajudam a oferecer líquidos com segurança quando não há restrição?
4. Por que não se deve apressar um paciente durante a refeição?
5. Que informações devem ser registradas após uma refeição com intercorrência?

Orientação de estudo: responda às questões com base no conteúdo do módulo original e neste aprofundamento. Quando houver dúvida sobre uma conduta prática, prevalecem o plano de cuidados, o protocolo institucional e a orientação da equipe responsável.

10. Medicamentos - Limites — Conteúdo Complementar

Carga adicional: 2 horas

Aprofundamento

A segurança medicamentosa depende de respeito à prescrição e aos limites do cuidador. O profissional pode ter funções de apoio definidas pelo protocolo, mas não deve improvisar doses, substituir medicamentos ou responder a pedidos familiares alterando o tratamento.

Conteúdos complementares

10.1 Conferência: verificar nome do paciente, medicamento e horário conforme orientação recebida.

10.2 Recusa: respeitar a decisão, registrar e comunicar conforme protocolo.

10.3 Efeitos observados: relatar sonolência excessiva, náuseas, erupções ou outras alterações.

10.4 Armazenamento: manter medicamentos organizados e fora do alcance de pessoas não autorizadas.

10.5 Pedidos de alteração: nunca modificar dose ou horário por conta própria; comunicar a equipe.

Atividades Complementares

1. Quais atividades relacionadas aos medicamentos podem fazer parte do apoio do cuidador?
2. Por que alterar a dose por solicitação familiar é inadequado?
3. Como proceder quando o paciente recusa um medicamento?
4. Cite três efeitos que devem ser comunicados à equipe.
5. Por que medicamentos de pessoas diferentes não devem ser compartilhados?

Orientação de estudo: responda às questões com base no conteúdo do módulo original e neste aprofundamento. Quando houver dúvida sobre uma conduta prática, prevalecem o plano de cuidados, o protocolo institucional e a orientação da equipe responsável.

11. Sondas e Ostomias — Conteúdo Complementar

Carga adicional: 2 horas

Aprofundamento

O cuidador atua principalmente na observação, higiene do entorno, posicionamento e comunicação. Alterações na fixação, fluxo, pele ou aspecto do estoma devem ser registradas e encaminhadas. Não se deve tentar recolocar uma sonda deslocada.

Conteúdos complementares

- 11.1 Sondas: verificar fixação, tração, dobras e sinais de saída accidental.
- 11.2 Pele: observar irritação, secreção, dor e lesões no local de fixação.
- 11.3 Ostomias: observar cor, umidade, integridade da pele e vazamentos.
- 11.4 Drenagem: acompanhar aspecto e volume quando isso fizer parte do protocolo.
- 11.5 Intercorrências: interromper o que possa agravar a situação e comunicar a enfermagem.

Atividades Complementares

1. Quais itens devem ser observados na fixação de uma sonda?
2. Que alterações na pele ao redor da sonda devem ser comunicadas?
3. Como deve ser o aspecto esperado de um estoma saudável?
4. O que fazer se uma sonda parecer deslocada?
5. Por que o cuidador não deve tentar recolocar uma sonda?

Orientação de estudo: responda às questões com base no conteúdo do módulo original e neste aprofundamento. Quando houver dúvida sobre uma conduta prática, prevalecem o plano de cuidados, o protocolo institucional e a orientação da equipe responsável.

12. Curativos e Pele — Conteúdo Complementar

Carga adicional: 2 horas

Aprofundamento

A pele funciona como barreira de proteção e merece inspeção diária. O cuidador deve reconhecer sinais de agravamento e respeitar o limite entre cuidados básicos e procedimentos de enfermagem. Registros objetivos facilitam a continuidade do tratamento.

Conteúdos complementares

12.1 Inspeção: observar cor, temperatura, edema, dor, secreção e odor.

12.2 Hidratação: aplicar produtos apenas conforme orientação e respeitar áreas lesionadas.

12.3 Proteção: manter pele limpa e seca e reduzir atrito e pressão.

12.4 Curativos: executar apenas o que estiver previsto em orientação e treinamento.

12.5 Comunicação: relatar mudanças comparando com o aspecto anterior, sem diagnosticar.

Atividades Complementares

1. Quais sinais podem sugerir infecção em uma lesão?
2. Por que manter a pele limpa e seca é importante?
3. Quando o cuidador pode realizar um curativo básico?
4. Como descrever uma alteração de pele de forma objetiva?
5. Por que não se deve diagnosticar uma lesão apenas pela aparência?

Orientação de estudo: responda às questões com base no conteúdo do módulo original e neste aprofundamento. Quando houver dúvida sobre uma conduta prática, prevalecem o plano de cuidados, o protocolo institucional e a orientação da equipe responsável.

13. Mobilização, Transferências e Quedas — Conteúdo Complementar

Carga adicional: 2 horas

Aprofundamento

A mobilização segura começa antes do movimento. O cuidador deve avaliar o ambiente, explicar a tarefa, verificar apoio disponível e utilizar dispositivos corretamente. A prevenção de quedas inclui fatores físicos, comportamentais e ambientais.

Conteúdos complementares

13.1 Antes da transferência: verificar calçados, travas, altura e espaço.

13.2 Comunicação: combinar sinais simples para iniciar, parar e mudar de posição.

13.3 Ergonomia: manter base ampla, aproximar-se do paciente e evitar torções.

13.4 Dispositivos: conferir estado e posicionamento de cadeira de rodas, andador e barras.

13.5 Queda: proteger o paciente, avaliar sinais de trauma, chamar ajuda e registrar.

Atividades Complementares

1. Quais verificações devem ser feitas antes de uma transferência?
2. Por que o cuidador não deve puxar o paciente pelos braços?
3. Cite quatro medidas ambientais de prevenção de quedas.
4. Quando é necessário pedir ajuda para uma transferência?
5. Qual a conduta inicial após uma queda quando existe suspeita de trauma?

Orientação de estudo: responda às questões com base no conteúdo do módulo original e neste aprofundamento. Quando houver dúvida sobre uma conduta prática, prevalecem o plano de cuidados, o protocolo institucional e a orientação da equipe responsável.

14. Alzheimer, Parkinson, AVC, DM e HAS — Conteúdo Complementar

Carga adicional: 2 horas

Aprofundamento

As doenças crônicas e neurológicas exigem cuidados adaptados. O foco do cuidador é segurança, autonomia possível, observação e comunicação. A abordagem deve considerar o padrão habitual do paciente e as orientações da equipe.

Conteúdos complementares

- 14.1 Alzheimer: usar rotinas previsíveis, frases curtas, redirecionamento e ambiente seguro.
- 14.2 Parkinson: atenção à marcha, congelamento, equilíbrio e deglutição.
- 14.3 AVC: apoiar o lado afetado, estimular participação e observar sinais neurológicos novos.
- 14.4 Diabetes: reconhecer sinais de hipo e hiperglicemia e seguir o plano alimentar.
- 14.5 Hipertensão: observar sintomas, registrar medidas autorizadas e comunicar alterações relevantes.

Atividades Complementares

1. Como a rotina previsível ajuda uma pessoa com demência?
2. Cite dois cuidados específicos para Parkinson.
3. Como o cuidador deve apoiar uma pessoa com hemiplegia?
4. Quais sinais podem indicar hipoglicemia?
5. Que alterações em um paciente com hipertensão ou insuficiência cardíaca devem ser comunicadas?

Orientação de estudo: responda às questões com base no conteúdo do módulo original e neste aprofundamento. Quando houver dúvida sobre uma conduta prática, prevalecem o plano de cuidados, o protocolo institucional e a orientação da equipe responsável.

15. Primeiros Socorros — Conteúdo Complementar

Carga adicional: 2 horas

Aprofundamento

Em uma emergência, segurança da cena e acionamento de ajuda vêm antes de intervenções improvisadas. O cuidador deve atuar dentro do treinamento recebido e seguir protocolos. Treinamentos de primeiros socorros e RCP precisam ser atualizados periodicamente.

Conteúdos complementares

15.1 Cena segura: afastar riscos antes de aproximar-se.

15.2 Avaliação inicial: verificar responsividade e respiração conforme treinamento.

15.3 Acionamento: pedir ajuda e acionar o serviço de emergência quando indicado.

15.4 Convulsão: proteger contra traumas, não colocar objetos na boca e observar o tempo.

15.5 Queda e dor torácica: não minimizar sintomas; comunicar e acionar ajuda conforme gravidade.

Atividades Complementares

1. Qual deve ser a primeira preocupação ao chegar a uma emergência?
2. Como agir quando uma pessoa apresenta convulsão?
3. Quando uma queda exige maior cautela antes de movimentar o paciente?
4. Por que o cuidador deve atuar conforme seu treinamento em primeiros socorros?
5. Qual serviço de emergência médica deve ser acionado no Brasil em situações indicadas?

Orientação de estudo: responda às questões com base no conteúdo do módulo original e neste aprofundamento. Quando houver dúvida sobre uma conduta prática, prevalecem o plano de cuidados, o protocolo institucional e a orientação da equipe responsável.

16. Cuidados Paliativos — Conteúdo Complementar

Carga adicional: 2 horas

Aprofundamento

Nos cuidados paliativos, conforto, dignidade e qualidade de vida orientam as ações. O cuidador pode contribuir muito por meio da presença, higiene, posicionamento, ambiente confortável e comunicação de sintomas, sem alterar prescrições.

Conteúdos complementares

16.1 Conforto: ajustar posicionamento, roupa de cama, higiene e ambiente conforme preferências.

16.2 Comunicação: escutar sem pressionar o paciente a falar.

16.3 Sintomas: observar dor, falta de ar, ansiedade, náusea e alterações de consciência e comunicar.

16.4 Família: acolher emoções sem prometer resultados ou emitir opiniões clínicas.

16.5 Dignidade: preservar privacidade, escolhas possíveis e respeito em todas as etapas.

Atividades Complementares

1. Qual é o foco dos cuidados paliativos?
2. Como o cuidador pode contribuir para o conforto sem alterar prescrições?
3. Quais sintomas devem ser comunicados à equipe?
4. Como preservar a dignidade durante cuidados de higiene em fase avançada de doença?
5. Como acolher a família sem oferecer promessas ou opiniões clínicas?

Orientação de estudo: responda às questões com base no conteúdo do módulo original e neste aprofundamento. Quando houver dúvida sobre uma conduta prática, prevalecem o plano de cuidados, o protocolo institucional e a orientação da equipe responsável.

17. Comunicação e Família — Conteúdo Complementar

Carga adicional: 2 horas

Aprofundamento

A comunicação profissional reduz conflitos e melhora a continuidade do cuidado. O cuidador deve distinguir informação observada de interpretação, transmitir fatos com clareza e encaminhar questões clínicas à equipe responsável.

Conteúdos complementares

- 17.1 Escuta ativa: ouvir, confirmar entendimento e fazer perguntas abertas.
- 17.2 Passagem de informações: usar fatos observáveis, horário e contexto.
- 17.3 Conflitos: manter tom respeitoso, não discutir e acionar supervisão quando necessário.
- 17.4 Limites: não compartilhar informações além do autorizado.
- 17.5 Trabalho em equipe: reconhecer o papel de cada profissional e colaborar com a continuidade.

Atividades Complementares

1. O que caracteriza uma escuta ativa?
2. Como diferenciar fato observado de interpretação ao comunicar uma intercorrência?
3. Qual deve ser a postura diante de um familiar irritado?
4. Por que a passagem de plantão é importante?
5. Quando um conflito deve ser encaminhado à supervisão?

Orientação de estudo: responda às questões com base no conteúdo do módulo original e neste aprofundamento. Quando houver dúvida sobre uma conduta prática, prevalecem o plano de cuidados, o protocolo institucional e a orientação da equipe responsável.

18. Diário de Bordo — Conteúdo Complementar

Carga adicional: 2 horas

Aprofundamento

O registro profissional deve permitir que outra pessoa compreenda o que aconteceu. Registros objetivos ajudam a detectar tendências, acompanhar respostas e proteger paciente e profissional. A informação deve ser lançada o mais próximo possível do cuidado.

Conteúdos complementares

18.1 Objetividade: registrar fatos observados, evitando rótulos e opiniões.

18.2 Cronologia: indicar horário e sequência das ocorrências.

18.3 Dados relevantes: incluir sinais vitais, alimentação, hidratação, eliminações, mobilidade e intercorrências.

18.4 Comunicação: registrar a quem a informação foi comunicada e qual orientação foi recebida.

18.5 Correção: nunca inventar, apagar ou alterar informações para esconder falhas.

Atividades Complementares

1. Quais características tornam um registro profissional confiável?
2. Por que registrar o horário das ocorrências?
3. Quais cuidados do cotidiano podem aparecer no Diário de Bordo?
4. Como registrar uma falha percebida após o horário do cuidado?
5. Por que nunca se deve inventar uma informação para preencher uma lacuna?

Orientação de estudo: responda às questões com base no conteúdo do módulo original e neste aprofundamento. Quando houver dúvida sobre uma conduta prática, prevalecem o plano de cuidados, o protocolo institucional e a orientação da equipe responsável.

19. Autocuidado e Burnout — Conteúdo Complementar

Carga adicional: 2 horas

Aprofundamento

O cuidado contínuo pode gerar sobrecarga. Reconhecer sinais de estresse e esgotamento favorece decisões mais seguras. O autocuidado inclui descanso, limites, organização, apoio e procura de ajuda quando necessário.

Conteúdos complementares

19.1 Sinais de alerta: irritabilidade, cansaço persistente, perda de motivação e distanciamento emocional.

19.2 Rotina: organizar pausas e horários de descanso sempre que possível.

19.3 Ergonomia: pedir ajuda em transferências que excedam a capacidade individual.

19.4 Limites: não levar conflitos do plantão para a vida pessoal.

19.5 Apoio: comunicar sobrecarga à coordenação e buscar avaliação profissional quando necessário.

Atividades Complementares

1. Cite quatro sinais de possível sobrecarga profissional.
2. Como a organização dos horários pode ajudar na prevenção do esgotamento?
3. Por que ergonomia também é uma medida de autocuidado?
4. Quando o cuidador deve pedir ajuda à coordenação?
5. Como separar vida profissional e pessoal pode favorecer a qualidade do cuidado?

Orientação de estudo: responda às questões com base no conteúdo do módulo original e neste aprofundamento. Quando houver dúvida sobre uma conduta prática, prevalecem o plano de cuidados, o protocolo institucional e a orientação da equipe responsável.

20. Ética e Legislação — Conteúdo Complementar

Carga adicional: 2 horas

Aprofundamento

A responsabilidade profissional envolve conhecer limites, preservar sigilo e agir de forma diligente. Negligência, imprudência e imperícia descrevem formas diferentes de conduta inadequada. O cuidador deve seguir legislação aplicável, contrato e protocolos da instituição.

Conteúdos complementares

- 20.1 Negligência: reconhecer situações em que uma obrigação de cuidado foi omitida.
- 20.2 Imprudência: evitar decisões precipitadas ou ações sem as verificações necessárias.
- 20.3 Imperícia: não executar tarefas para as quais não possui treinamento ou habilitação.
- 20.4 Sigilo: proteger dados de saúde, imagens, documentos e conversas.
- 20.5 Responsabilidade: registrar, comunicar intercorrências e buscar orientação diante de dúvidas.

Atividades Complementares

1. Explique com suas palavras a diferença entre negligência, imprudência e imperícia.
2. Por que o sigilo é uma responsabilidade contínua?
3. Que tipos de dados do paciente precisam ser protegidos?
4. Como agir quando não se tem segurança para realizar uma tarefa?
5. Por que registros objetivos também fazem parte da responsabilidade profissional?

Orientação de estudo: responda às questões com base no conteúdo do módulo original e neste aprofundamento. Quando houver dúvida sobre uma conduta prática, prevalecem o plano de cuidados, o protocolo institucional e a orientação da equipe responsável.

GABARITO — ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Respostas de referência para as 100 questões adicionadas. Respostas equivalentes, quando coerentes com o conteúdo da apostila, podem ser consideradas corretas.

1. Papel do Cuidador

1. Porque evita atuação fora do escopo e reduz riscos ao paciente.
2. Quando houver procedimento fora da função, dúvida relevante, intercorrência ou mudança importante no estado do paciente.
3. Oferecendo ajuda apenas no necessário, permitindo participação e mantendo supervisão nas situações de risco.
4. Mudanças no estado de saúde, cuidados realizados, recusas, intercorrências e orientações recebidas.
5. Não realizar o procedimento, explicar o limite, comunicar a supervisão/equipe e registrar quando indicado.

2. Ética e Humanização

1. Porque respeita autonomia e dignidade e permite participação consciente no cuidado.
2. Cobrir o corpo, fechar portas/cortinas e evitar exposição ou conversas indevidas.
3. Manter calma, ouvir, explicar fatos objetivamente e acionar supervisão se necessário.
4. Porque podem expor dados sensíveis e violar a privacidade do paciente.
5. Ser acolhedor mantém respeito e limites; ultrapassar limites envolve exposição, intimidade inadequada ou decisões fora da função.

3. Anatomia e Fisiologia

1. Porque sua função é observar, apoiar e comunicar, não diagnosticar.
2. Confusão súbita, fala alterada, perda de força, convulsão ou alteração da consciência.
3. Esforço, profundidade, ruídos, uso de musculatura acessória e coloração.
4. Vermelhidão, feridas, bolhas, hematomas e lesões por pressão.
5. Porque mudanças em relação ao padrão individual podem indicar intercorrência mesmo quando o número isolado parece pouco alterado.

4. Envelhecimento e Doenças

1. Porque o envelhecimento é individual e capacidades, doenças e contextos variam.
2. Diminuição de visão/audição, menor força, equilíbrio reduzido, reflexos mais lentos.
3. Alteração súbita de orientação, sono, apetite, humor ou comportamento.
4. Retirando obstáculos, melhorando iluminação e mantendo apoio e organização.
5. Porque cada paciente possui necessidades e riscos diferentes e deve seguir um plano individual.

5. Biossegurança

1. Prevenir acidentes e reduzir transmissão de microrganismos.
2. Porque as mãos podem contaminar-se ao colocar/retirar luvas e em outras etapas do cuidado.
3. Entre procedimentos e quando houver troca de paciente ou risco de contaminação.
4. Interromper com segurança, lavar a área, comunicar o responsável e seguir o protocolo.
5. Porque evita acidentes e exposição ao material perfurocortante.

6. Sinais Vitais

1. Repouso insuficiente, posição inadequada, falar durante a medida, manguito incorreto, esforço recente.
2. Porque o padrão individual ajuda a reconhecer mudanças relevantes.
3. Horário, valor, método/via, posição/condições e observações relevantes.
4. Profundidade, esforço, ritmo, ruídos e coloração.
5. Porque dor pode ser a principal manifestação de uma intercorrência e precisa ser comunicada.

7. Higiene e Banho no Leito

1. Para reunir materiais, organizar ambiente e evitar exposição ou interrupções.
2. Cobrir áreas não higienizadas, fechar portas/cortinas e explicar as etapas.
3. Axilas, virilha, sob as mamas e entre os dedos.
4. Permitir que faça etapas que consegue e oferecer ajuda apenas onde necessário.
5. Registrar e comunicar conforme a gravidade e o protocolo, evitando agravar a área.

8. Decúbito e Prevenção de LPP

1. Pressão prolongada/intensa, cisalhamento, umidade e mobilidade reduzida.
2. Porque aumenta atrito e cisalhamento, podendo lesionar tecidos.
3. Redistribuir pressão e manter alinhamento corporal.
4. Para identificar precocemente alterações e orientar medidas preventivas.
5. Aliviar a pressão, proteger a região, registrar e comunicar à enfermagem.

9. Nutrição, Hidratação e Disfagia

1. Porque a consistência prescrita reduz risco de engasgo e aspiração.
2. Engasgo, tosse, voz molhada, escape de alimento e demora para engolir.
3. Oferecer pequenas quantidades em intervalos regulares, respeitando orientação e restrições.
4. Porque aumenta risco de engasgo e reduz a capacidade de coordenar a deglutição.
5. Aceitação, quantidade aproximada quando prevista, recusa e sinais de engasgo/tosse ou outras intercorrências.

10. Medicamentos - Limites

1. Lembrar horários, levar medicamento se autorizado, observar a tomada quando previsto e registrar recusas/efeitos.
2. Porque altera tratamento sem autorização e pode causar dano.
3. Respeitar a recusa, registrar e comunicar conforme protocolo.
4. Náusea, sonolência, erupção, alteração de comportamento ou outros efeitos observados.
5. Porque o medicamento é individual e a troca pode ser perigosa.

11. Sondas e Ostomias

1. Fixação, tração, dobras, posição e sinais de saída acidental.
2. Vermelhidão, secreção, dor, irritação ou lesão.
3. Úmido e rosado/avermelhado, conforme o conteúdo original da apostila.
4. Não manipular para recolocar; interromper o que possa passar pela sonda e comunicar a enfermagem.
5. Porque a recolocação é procedimento que exige habilitação e pode causar complicações.

12. Curativos e Pele

1. Calor, pus, odor, aumento de dor, vermelhidão ou secreção.
2. Reduz risco de irritação e proliferação de microrganismos.
3. Quando houver orientação, treinamento e protocolo para aquele cuidado.

4. Descrever cor, tamanho/aparência, secreção, odor, dor e momento observado, sem diagnóstico.
5. Porque diagnóstico e decisão terapêutica pertencem à equipe habilitada.

13. Mobilização, Transferências e Quedas

1. Explicar, verificar calçados, travar rodas, ajustar posição e garantir espaço.
2. Porque pode causar lesão nos ombros e perda de equilíbrio.
3. Boa iluminação, retirar tapetes/obstáculos, barras de apoio e calçados seguros.
4. Quando o paciente for pesado, pouco colaborativo, instável ou quando o procedimento exigir duas pessoas.
5. Não levantar imediatamente; avaliar segurança, consciência e dor, chamar ajuda e comunicar.

14. Alzheimer, Parkinson, AVC, DM e HAS

1. Reduz confusão, facilita orientação e diminui situações inesperadas.
2. Acompanhar marcha/equilíbrio e observar deglutição; usar dispositivos conforme orientação.
3. Apoiar o lado afetado e adaptar o vestir, estimulando participação.
4. Sudorese, tremores, fome, confusão e irritabilidade.
5. Edema, falta de ar, dor, alterações importantes de pressão ou ganho súbito de peso conforme plano.

15. Primeiros Socorros

1. Garantir segurança da cena.
2. Proteger a cabeça, afastar objetos, não colocar nada na boca, observar o tempo e acionar ajuda quando necessário.
3. Quando houver suspeita de fratura, trauma craniano, dor intensa ou alteração de consciência.
4. Porque intervenções além da competência podem aumentar o risco.
5. SAMU 192.

16. Cuidados Paliativos

1. Aliviar sofrimento, promover conforto, qualidade de vida e dignidade.
2. Com higiene, posicionamento, presença, escuta e comunicação de sintomas.
3. Dor, falta de ar, ansiedade, náusea, agitação ou alterações de consciência.
4. Cobrir o corpo, explicar os cuidados, respeitar preferências e preservar privacidade.
5. Ouvir, acolher e comunicar à equipe, sem prometer cura ou emitir condutas clínicas.

17. Comunicação e Família

1. Ouvir sem interromper, confirmar entendimento e fazer perguntas pertinentes.
2. Fato é o que foi observado; interpretação é uma conclusão que deve ser evitada no registro/comunicação.
3. Manter calma, ouvir, explicar objetivamente e buscar supervisão se necessário.
4. Garantir que informações e cuidados continuem de forma segura entre profissionais.
5. Quando ultrapassar a capacidade de resolução do cuidador, envolver segurança ou afetar o cuidado.

18. Diário de Bordo

1. Ser verdadeiro, objetivo, legível, completo e próximo do horário do cuidado.
2. Permite reconstruir a sequência e localizar alterações com precisão.
3. Sinais vitais, alimentação, hidratação, eliminações, higiene, mobilidade, recusas e intercorrências.
4. Registrar com honestidade o horário real ou aproximado e comunicar a supervisão se necessário.
5. Porque um registro falso compromete a segurança, a continuidade e a responsabilidade profissional.

19. Autocuidado e Burnout

1. Irritabilidade, sono prejudicado, cansaço persistente, perda de motivação e distanciamento emocional.
2. Permite respeitar descanso e reduzir acúmulo de tarefas.
3. Reduz sobrecarga física e risco de lesões.
4. Quando houver excesso de jornada, cansaço que afete o cuidado ou dificuldade de manter segurança.
5. Ajuda a evitar que o estresse do trabalho comprometa relações e decisões fora e dentro do plantão.

20. Ética e Legislação

1. Negligência é deixar de fazer o que deveria; imprudência é agir de forma precipitada; imperícia é executar sem habilitação/conhecimento adequado.
2. Porque a obrigação de proteger informações continua após o atendimento.
3. Dados de saúde, imagens, documentos, receitas, endereço e informações do atendimento.
4. Parar e buscar orientação da supervisão/equipe antes de realizar.
5. Porque documentam fatos, decisões e comunicações e favorecem continuidade e responsabilização adequada.

Encerramento da ampliação

Com a conclusão das atividades complementares, o curso passa a considerar 40 horas adicionais aos 160 horas da apostila-base, totalizando 200 horas de formação. A prova final original permanece como instrumento de avaliação do material-base.